TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OLÍMPIA
FORO DE OLÍMPIA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
Rua São João, 865, Olímpia-SP - CEP 15400-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1005376-74.2024.8.26.0400**
Classe - Assunto	**Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Fornecimento de medicamentos**
Requerente:	**Mario Pereira Oliveira**
Requerido:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA e outro**

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alexandre Cesar Ribeiro**

Vistos.

Trata-se de ação condenatória, proposta por **Mário Pereira Oliveira** contra a **Fazenda do Estado de São Paulo** e contra a **Prefeitura Municipal de Olímpia**, visando à condenação solidária dos réus ao fornecimento solidário e gratuito, de ***dieta enteral padrão*** com fibras, sem adição de sacarose e lactose e isenta de glúten; uma vez que o demandante padece de síndrome demencial em estágio avançado, em uso de gastrostomia, fazendo apenas uso de alimentação enteral em razão de disfagia.

Relatórios dispensado.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela **Prefeitura de Olímpia**, pois a responsabilidade pela garantia de preservação de direitos constitucionais é solidária entre os entes federativos (*cf.* Tema nº 793 da Repercussão Geral: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.").

Inexiste norma que exima as rés do atendimento à saúde e assistência social das pessoas carentes. A seguridade social é financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da *União, Distrito Federal, Estados e Municípios* (art. 195, Constituição Federal). Uma das diretrizes básicas das ações governamentais de assistência social é justamente a *descentralização político-administrativa*; cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal. A jurisprudência brasileira entende que a obrigação de cuidar da saúde é solidária entre os entes da federação.

Outrossim, a Constituição Estadual (art. 219), dispõe que*: "A saúde é direito de todos e dever do Estado. Parágrafo único - O poder Público Estadual e Municipal garantirá o direito à saúde, mediante: (...) 2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

os níveis: (...) 4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde".

Já a lei regulamentadora do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/90), em seu artigo 6º, inciso I, letra *d*, dispõe que:

> *Art. 6º. Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS:*
> *I - A execução de ações:*
> *(...)*
> *d - de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.*

A obrigação compete inicialmente ao **município** em relação às ações e serviços de assistência integral à saúde, alimentação e nutrição, atuando o Estado de forma articulada na execução dessas atividades.

No mais, procede-se ao julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de outras provas para a solução da controvérsia (art. 355, I, Código de Processo Civil).

A ação é **improcedente**.

A Constituição Federal (art. 23, II), dispõe ser de *competência comum* dos entes da Federação *cuidar da saúde e da assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência*. Assim, são solidariamente responsáveis as entidades federativas no cumprimento dos ditames referentes à saúde pública, dentre os quais o fornecimento de remédios, equipamentos e realização de exames e tratamentos médicos.

A mesma Constituição Federal (artigo 196) dispõe que: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O artigo 196 da Constituição Federal tem plena aplicabilidade e eficácia, pois se refere a direitos individuais e coletivos e que dispensam regulamentação por força de mandamento da própria Constituição (art. 5º, § 1º, Constituição Federal).

Nesse sentido:

> O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

> infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF, AgR no RE 271286/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, J. 12/09/2000, DJ 24/11/2000, p. 101).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do **Tema nº 106 dos recursos repetitivos**, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; ii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.".

Porém, referida tese ficou **superada** pelo julgamento do **Tema nº 6 da Repercussão Geral**, que ensejou a **Súmula Vinculante nº 61**, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)".

Em referido recurso extraordinário, que **integra o enunciado dessa Súmula Vinculante**, assentou-se:

> **1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.** 2. É possível, **excepcionalmente**, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: **(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.** 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No **Tema nº 1.234 da repercussão geral**, o mesmo Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I − Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG − situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. **II − Definição de Medicamentos Não Incorporados.** 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos *off label* sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. **III − Custeio.** 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) **Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o *venire contra factum proprium/tuquoque* e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. **IV − Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V − Plataforma Nacional.** 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

> mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. **VI − Medicamentos incorporados.** 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.

Nesse julgamento, observou-se nas alíneas "b" e "c" do item 6.1, que: "até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento; c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento − em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU −, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985".

Por decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, no acórdão dos sextos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, foram feitos os seguintes esclarecimentos, sem efeitos modificativos: "Para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OLÍMPIA
FORO DE OLÍMPIA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
Rua São João, 865, Olímpia-SP - CEP 15400-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.".

À sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em 11/12/2024, no julgamento nos Conflitos de Competência nºs 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, em juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.040, II, do Código de Processo Civil, **revogou** as teses fixadas no IAC nº 14 do STJ, por contrariedade ao Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Com base nesses julgamentos, a **Súmula Vinculante nº 60** do Supremo Tribunal Federal estabelece que *"o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais) devem observar os termos dos três acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral".*

Em linhas gerais, pode-se extrair, das extensas e complexas proposições dos temas e súmulas retromencionados, o seguinte:

> **I. Competência: a) Justiça Federal**: demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico for igual ou superior a 210 salários mínimos; **b) Justiça Estadual**: demandas cujo valor do tratamento anual seja inferior a 210 salários mínimos.
>
> **II. Conceitos de Medicamentos Incorporados e Não Incorporados: a) Incorporados**: que constam nas listas de dispensação do SUS (RENAME, RESME, REMUME etc.); **b) Não Incorporados**: que não constam nas listas do SUS, incluindo medicamentos *off label* e sem registro na ANVISA.
>
> **III. Requisitos para propor a ação judicial de medicamentos:** a) Negativa de fornecimento na via administrativa; b) Ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec ou ausência de pedido de incorporação; c) Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; d) Eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, comprovadas por evidências científicas de alto nível; e) Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado que descreva a necessidade clínica do tratamento, incluindo os tratamentos já realizados e a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; e f) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.
>
> **IV. Condições para o Judiciário determinar o fornecimento de medicamentos: a) Medicamentos incorporados:** seguir o fluxo administrativo e judicial acordado entre os Entes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

Federativos; **b) Medicamentos não incorporados:** análise da legalidade do ato administrativo de não incorporação e a negativa de fornecimento, e dos requisitos de dispensação do medicamento, com demonstração, com base em evidências científicas de alto nível, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento. Observa-se que, para verificação desses requisitos, o Judiciário deve utilizar os seguintes recursos para analisar a necessidade da medicação não incorporada: 1. **Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)**: Sempre que disponível na jurisdição, o NATJUS deve ser consultado para fornecer pareceres técnicos sobre a necessidade e a eficácia do medicamento solicitado; 2. **Especialistas técnicos**: Em caso de ausência do NATJUS, o Judiciário pode consultar entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde para obter uma avaliação detalhada sobre o medicamento; e 3. **Análise do ato administrativo**: O Judiciário deve obrigatoriamente analisar o ato administrativo de não incorporação pela Conitec ou a negativa de fornecimento na via administrativa, considerando as circunstâncias do caso concreto e a legislação vigente, especialmente a política pública do SUS. E antes da decisão, **o Judiciário deve consultar o NATJUS ou especialistas técnicos para garantir que <u>a decisão não se baseie apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pelo autor da ação</u>**. Caso o medicamento seja deferido judicialmente, o Judiciário deve oficiar aos órgãos competentes para avaliar a possibilidade de sua incorporação no SUS.

V. Responsabilidades individuais da União, dos Estados e dos Municípios: a) União: custeio integral das ações de fornecimento de medicamentos não incorporados que se inserirem na competência da Justiça Federal; **b) Estados e Municípios:** nas ações de competência da Justiça Estadual e que cuidem de medicamentos não incorporados, haverá ressarcimento pela União, via repasses, Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS); sendo esse ressarcimento será de 65% dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos.

Em relação a tratamento Oncológico: a) Para ações ajuizadas antes de 10 de junho de 2024, a União ressarcirá 80% do valor total pago por Estados e Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão; b) Para casos posteriores a 10 de junho de 2024, o ressarcimento deverá ser pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Sobre a divisão de competências administrativas, caberá: a) à União (Ministério da Saúde): financiamento dos medicamentos do Grupo 1A e 1B do CEAF; aquisição centralizada e distribuição à SESA dos medicamentos do Grupo 1A do CEAF; financiamento tripartite dos medicamentos do Grupo 3 do CEAF; e elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); **b) aos Estados** (**Secretaria Estadual da Saúde):** recebimento, armazenamento e distribuição às Regionais de Saúde e aos municípios dos medicamentos do Grupo 1A do CEAF; aquisição com recurso federal, recebimento, armazenamento e distribuição às Regionais de Saúde e aos municípios dos medicamentos do Grupo 1B do CEAF; financiamento, aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição às Regionais de Saúde e aos municípios dos medicamentos do Grupo 2 do CEAF; financiamento tripartite dos medicamentos do Grupo 3 do CEAF; e acolhimento, avaliação e autorização dos processos de solicitação de medicamentos e dispensação aos usuários; e **c) aos Municípios (Secretarias Municipais da Saúde):** financiamento tripartite dos medicamentos do Grupo 3 do CEAF.

VI. Forma de aquisição do medicamento em caso de concessão judicial: deve se dar pelo **valor de venda com desconto proposto no processo de incorporação na Conitec** ou pelo **valor já praticado em compra pública**, **<u>limitado ao teto do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG)</u>**.

Referido julgamento (do Supremo Tribunal Federal) **não é claro** sobre sua aplicação em relação aos **<u>insumos</u>**, como *fraldas, instrumentos médicos, alimentos especiais* e **<u>exames</u>** médicos.

Contudo, este Juiz entende que, por *analogia* e *interpretação lógica*, é necessária a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

aplicação do mesmo raciocínio dos julgamentos supra também em relação aos insumos, alimentos especiais, próteses, órteses, e exames; sob pena de desvirtuamento do sistema de saúde do Brasil. Assim, se determinado insumo, alimento especial, exame prótese ou órtese não são fornecidos pelo SUS, em princípio, eles **não** podem ser determinados judicialmente; salvo nas hipóteses na Súmula Vinculante nº 61 do Supremo Tribunal Federal.

Essa Súmula Vinculante representou importante avanço na interpretação do direito à saúde. Não se pode exigir que o Estado forneça tudo a todos segundo suas necessidades. É necessário haver um parâmetro e um limite do que pode ou não ser custeado pelo poder público; sob pena de se inviabilizar o Sistema Único de Saúde. Em nenhum lugar do mundo (nem mesmo em países comunistas ou socialistas) o Estado fornece integralmente tudo o que se prescreve para tratamento de saúde. E o Judiciário não pode, por meio de demandas individuais, alterar políticas públicas de acesso à saúde, sob pena de desvirtuar a própria política pública.

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet (*As Súmulas 60 e 61 do STF e a assim chamada 'judicialização da saúde'*; disponível na internet, em https://www.conjur.com.br/2024-out-25/as-sumulas-60-e-61-do-stf-e-a-assim-chamada-judicializacao-da-saude/. Acessado em 21/03/2025), "[...] as objeções/críticas referidas não afastam a possibilidade de se pleitear em juízo a satisfação de bens e serviços destinados a salvaguardar o direito à saúde, mesmo nos casos de medicamentos não incorporados ao SUS e/ou não aprovados pela Anvisa, mas apontam para a necessidade de contínua reflexão e aperfeiçoamento de critérios e instrumentos. De especial relevância são medidas (de todos os atores públicos, mas também da sociedade civil) destinadas a combater a má governança, incluindo a corrupção, o desperdício, a falta de racionalização e de planejamento, o financiamento insuficiente, a falta de informações adequadas e de transparência, entre outros fatores, sem o que uma efetividade desejável do direito à saúde (aliás, de todos os direitos fundamentais) não será jamais – com ou sem atuação do Poder Judiciário – alcançada. **Não seria realista, ao fim e ao cabo, querer a absoluta eliminação das intervenções do Judiciário, mas também não se revelaria razoável apostar em uma política de saúde corrigida e guiada substancialmente por decisões judiciais. O amadurecimento da jurisprudência, por meio do reconhecimento gradual de critérios para a concessão ou denegação de pleitos, demonstra o acerto da opção por um caminho intermediário, de natureza prudencial, que simultaneamente assegure a primazia dos poderes Legislativo e Executivo na matéria, mas que não esvazie o relevante papel do Poder Judiciário, em particular aqui do STF, como guardião da Constituição e dos direitos fundamentais. Nessa perspectiva, parece correto – ao menos é o que se sugere – que as Súmulas 60 e 61, representam um avanço importante para que a judicialização da saúde se torne cada vez mais 'saudável'**". (destaquei).

No caso dos autos, o pedido inicial envolvia o fornecimento gratuito de **fraldas geriátricas** e de **dieta enteral**. Porém, à fl. 72 a parte autora **desistiu** do pedido das fraldas,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

restringindo sua pretensão, nesta demanda, ao fornecimento da alimentação.

A comprovação da necessidade da dieta enteral veio apresentada pelo receituário e formulário médicos de fls. 17/19 e 24/25; uma vez que a parte demandante sofre de **síndrome demencial em estágio avançado, fazendo uso de alimentação enteral definitiva** devido à *disfagia*, estando em uso de *gastrostomia*.

Contudo, **não há elementos** que demonstrem a necessidade e indispensabilidade do uso da dieta enteral no caso.

Conforme Nota Técnica do NAT-Jus produzida nestes autos, "A solicitação da dieta enteral industrializada e suplemento alimentar no setor público é realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e tem o propósito de atender aos pacientes assistidos pela rede pública ou privada. A solicitação de dieta enteral para a Secretaria Estadual de Saúde pode ser realizada por requerimento de nutrição enteral não disponibilizada pelo SUS, em caráter de excepcionalidade, apresentando a documentação necessária conforme as regras estabelecidas e disponíveis no site da Secretaria Estadual de Saúde – Comissão Farmacêutica.". "A Nutrição Enteral (NE) segundo RDC/63 ANVISA é um alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.". "Não há legislação que disponibilize dieta enteral industrializada pelo SUS a nível domiciliar/ambulatorial e não há recomendação da CONITEC determinando o fornecimento de dieta enteral industrializada para uso domiciliar. Não há evidência de benefício de suplementação nutricional em desfechos clínicos relevantes.".

Em relação ao caso dos autos, a Nota Técnica ponderou que "Pacientes com doenças avançadas devem ter acesso a um plano dietético adaptado ao seu momento clínico. **Os suplementos alimentares não são considerados essenciais ao manejo crônico ambulatorial e não se pode determinar neste caso uma excepcionalidade.** Além disso, considerando-se que suplementos não são medicamentos, é questionável a responsabilização do SUS na sua aquisição.". (destaquei).

Em suma, considerando que os documentos juntados aos autos **não** demonstram, de forma inequívoca, a **imprescindibilidade** da dieta enteral, que não se trata de insumo incorporado aos programas do SUS, e que houve parecer ***desfavorável pelo NAT-Jus***, a improcedência da ação é de rigor.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e julgo ***IMPROCEDENTE*** a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para ***rejeitar*** o pedido formulado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OLÍMPIA
FORO DE OLÍMPIA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
Rua São João, 865, Olímpia-SP - CEP 15400-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Observo que já foi **revogada** a tutela de urgência deferida *initio litis* (fls. 131).

Sem condenação em custas e em verbas da sucumbência nesta fase (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, arquivem os autos.

Publique-se e intimem. Ciência ao Ministério Público.

Olímpia, 9 de abril de 2025.

Alexandre César Ribeiro
Juiz de Direito
(assinatura digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR RIBEIRO, liberado nos autos em 09/04/2025 às 17:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005376-74.2024.8.26.0400 e código BRUeZumu.